Клинические рекомендации

Менингококковая инфекция у детей

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**A39** — Менингококковая инфекция **Z22.3** — Носительство возбудителей других уточненных бактериальных болезней
Пациенты	дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 03.03.2023, пересмотр не позднее 2026 года
Разработчик	Межрегиональная общественная организация "Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области"; Международная общественная организация "Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням"
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/58_2

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 28.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 2

2. Клиническая картина и классификация 2

2.1 Определение 2

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология 2

2.3 Классификация 3

2.4 Клиническая картина 3

3. Диагностика 3

3.1 Жалобы и анамнез 3

3.2 Физикальное обследование 3

3.3 Лабораторные исследования 4

3.4 Инструментальные исследования 4

4. Лечение 4

4.1 Локализованные формы 4

4.2 Генерализованные формы 5

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 5

5.1 Профилактика 5

5.2 Показания к госпитализации 6

6. Источник и актуальность 6

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 6

1. Основные положения

- Менингококковая инфекция — антропонозное заболевание с воздушно-капельным путём передачи; протекает как бактерионосительство, назофарингит, менингококкемия и гнойный менингит. Входные ворота — слизистые оболочки носо- и ротоглотки.
- **Признаки генерализованной формы**
  1. острейшее начало со стойкой фебрильной лихорадкой, часто двухволновой: вторая волна **через 2–6 часов** не снижается жаропонижающими;
  2. геморрагическая сыпь, не исчезающая при надавливании; ей нередко предшествует розеолёзная сыпь, принимаемая за аллергию;
  3. боли в мышцах, суставах, животе, головная боль, рвота, снижение диуреза.
- Назофарингит клинически не специфичен: диагноз устанавливается только при бактериологическом подтверждении. Локализованные формы лечат амбулаторно антибиотиками внутрь, если не требуется изоляция.
- При подозрении на генерализованную форму показана экстренная госпитализация в стационар с отделением реанимации; антибиотики на догоспитальном этапе вводят только при веских подозрениях (клиника и геморрагическая сыпь) и налаженном сосудистом доступе.
- При менингококковом менингите для раннего выявления поражения слухового анализатора исследуют акустические стволовые вызванные потенциалы (АСВП).

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Менингококковая инфекция — антропонозное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём и протекающее в виде бактерионосительства, назофарингита, менингококкемии и гнойного менингита, реже — с поражением других органов и систем.

2.2 Этиология, патогенез и эпидемиология

Возбудитель — Neisseria meningitidis, грамотрицательный диплококк; патогенны для человека серогруппы A, B, C, W, Y, X. Менингококк попадает на слизистую оболочку носоглотки, где быстро гибнет или вегетирует (носительство); в 10–15% случаев при сниженной резистентности и дефиците секреторного IgA развивается назофарингит. Генерализация сопровождается бактериемией, эндотоксинемией и системной воспалительной реакцией.

Группы риска генерализованных форм

1. дети раннего возраста, подростки, призывники;
2. лица, живущие в условиях скученности;
3. иммунодефициты;
4. кохлеарная имплантация, открытая черепно-мозговая травма, ликворея.

Эпидемиология

1. источник — носители и больные назофарингитом;
2. пути передачи — воздушно-капельный, контактно-бытовой;
3. инкубационный период **2–10 дней**, чаще 2–3 дня;
4. сезонность — зима и весна; периодичность подъёмов 28–30 лет.

В структуре заболеваемости носительство составляет 40–43%, назофарингит — 3–5%, менингококкемия — 36–43%, менингит — 10–25%, смешанная форма — 47–55%.

2.3 Классификация

Классификация В. И. Покровского

1. **локализованные формы** — менингококконосительство, острый назофарингит
2. **генерализованные формы** — менингококкемия (типичная, молниеносная, хроническая), менингит, менингоэнцефалит, смешанная форма
3. **редкие формы** — эндокардит, артрит (синовит), полиартрит, пневмония, иридоциклит

2.4 Клиническая картина

Для генерализованной формы характерно острейшее начало с внезапной вялостью на фоне фебрильной температуры. До появления геморрагической «звёздчатой» сыпи (элементы разбросаны, как звёзды на небе) заподозрить менингококковую природу вне очага практически невозможно.

Жизнеугрожающие осложнения

1. септический шок;
2. ДВС-синдром;
3. острая почечная недостаточность;
4. отёк головного мозга.

Лихорадка может быть двухволновой: после первого подъёма, который снижается парацетамолом или ибупрофеном, следует период относительного благополучия, затем повторный подъём, плохо поддающийся жаропонижающим.

---

3. Диагностика

3.1 Жалобы и анамнез

Что уточняют

1. контакты в семье и ближнем окружении;
2. пребывание в регионах с высокой заболеваемостью («менингитный пояс» Африки, Саудовская Аравия);
3. жалобы высокого риска генерализованной формы: острейшее начало, стойкая фебрильная лихорадка, геморрагическая сыпь, боли в мышцах, суставах, животе, головная боль, рвота, снижение диуреза.

Боли в животе и конечностях на фоне лихорадки относятся к «красным флагам» генерализованных бактериальных инфекций и нередко предшествуют септическому шоку. Распространённая геморрагическая сыпь без предшествующей розеолёзной через несколько часов от дебюта свидетельствует о крайней тяжести.

3.2 Физикальное обследование

Генерализованную форму предполагают при геморрагической сыпи, не исчезающей при надавливании, на фоне лихорадки.

Для оценки тяжести оценивают

1. уровень сознания;
2. температуру и окраску кожи, время капиллярного наполнения;
3. АД, частоту и характер дыхания, диурез;
4. менингеальные и очаговые симптомы.

3.3 Лабораторные исследования

Всем при подозрении на генерализованную форму

1. общий и биохимический анализы крови, кислотно-основное состояние и газы крови;
2. СРБ и прокальцитонин;
3. гемостаз: время кровотечения и свёртываемости, коагулограмма;
4. посев крови на стерильность;
5. посев слизи с задней стенки глотки и со слизистой оболочки носа на менингококк — вне зависимости от формы;
6. ПЦР крови на ДНК менингококка.

Исследование ЦСЖ при подозрении на смешанную форму или менингит

1. цитоз;
2. белок, глюкоза, натрий, хлориды, лактат;
3. посев, ПЦР на ДНК менингококка;
4. реакция латекс-агглютинации, микроскопия мазка по Граму.

Диагноз менингококкового менингита устанавливается только по результатам исследования ЦСЖ.

1. **достоверный диагноз** — типичная клиника локализованной или генерализованной формы и выделение культуры менингококка из стерильных жидкостей (кровь, ликвор, синовиальная жидкость) либо ДНК при ПЦР
2. **вероятный диагноз** — характерные клинико-лабораторные проявления при отрицательном бактериологическом обследовании

3.4 Инструментальные исследования

1. **ЭКГ и эхокардиография** — всем с генерализованной формой
2. **рентгенография грудной клетки** — при подозрении на пневмонию, в ОРИТ
3. **УЗИ головного мозга** — при подозрении на бактериальный гнойный менингит
4. **офтальмоскопия** — перед спинномозговой пункцией при подозрении на менингит
5. **ЭЭГ** — при отёке мозга, судорогах, энцефалопатии
6. **КТ или МРТ головного мозга** — при новой очаговой симптоматике, затяжном менингите без санации ЦСЖ

Пациентам с менингококковым менингитом исследуют акустические стволовые вызванные потенциалы: метод выявляет на ранних сроках повреждение слухового анализатора, которое может развиться при генерализованной форме и менингите, и позволяет оценить состояние стволовых структур мозга.

При экзантеме проводят дифференциальную диагностику с заболеваниями, протекающими с геморрагической и пятнисто-папулёзной сыпью; при плеоцитозе ЦСЖ — с менингитами иной этиологии и неинфекционными заболеваниями.

4. Лечение

4.1 Локализованные формы

Применяют средние терапевтические дозы антибиотиков, активных в отношении N. meningitidis, в формах для приёма внутрь: пенициллины широкого спектра (ампициллин, амоксициллин), комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз.

1. ампициллин, масса тела до 20 кг: 12,5–25 мг/кг в сутки (так в тексте КР, см. «Неточности»);
2. ампициллин, масса тела более 20 кг: 250–500 мг каждые 6 часов.

Детям с локализованными формами проводят коротковолновое ультрафиолетовое облучение зева и носа, лазеротерапию.

4.2 Генерализованные формы

Антибиотики вводят только парентерально, при подозрении на гнойный менингит — в максимальных для возраста дозах.

1. **без септического шока** — допустимо внутримышечно
2. **септический шок** — только внутривенно или внутрикостно
3. **нет геморрагической сыпи, подозрение на гнойный менингит** — антибиотик до госпитализации — только если госпитализация невозможна **в течение 90 минут**; до этого берут кровь, ЦСЖ, мазки из носоглотки

Препараты первого выбора — цефалоспорины III поколения (цефтриаксон несовместим с растворами, содержащими кальций). Меропенем назначают при вторичных бактериальных осложнениях в ОРИТ и выраженной нейтропении. Хлорамфеникол — детям **старше 3 лет** только при тяжёлой аллергии на бета-лактамы.

Глюкокортикоиды при установленной менингококковой этиологии менингита не рекомендуются; положительных эффектов при менингококковом менингите не выявлено.

1. **дексаметазон** — снижает частоту сенсоневральной тугоухости лишь при гемофильном менингите, если введён до антибиотика
2. **гидрокортизон** — заместительная терапия при септическом шоке, резистентном к адренергическим и дофаминергическим средствам

Патогенетическая и интенсивная терапия

1. инфузионная терапия для поддержания объёма циркулирующей крови и коррекции метаболических нарушений;
2. иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения;
3. осмодиуретики при отёке мозга, кардиотоники при шоке, рефрактерном к жидкостной нагрузке;
4. экстракорпоральная гемокоррекция при септическом шоке и синдроме Уотерхауса — Фридериксена;
5. перевод на ИВЛ при рефрактерном шоке, церебральной недостаточности (**менее 9 баллов** по шкале Глазго), судорожном статусе.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Профилактика

Лицам, находившимся в тесном контакте с больным, проводится экстренная химиопрофилактика.

1. рифампицин старше 12 месяцев: 10 мг/кг каждые 12 часов 2 дня;
2. рифампицин до 1 года: 5 мг/кг каждые 12 часов 2 дня;
3. цефтриаксон: 125 мг в/м однократно.

В межэпидемический период вакцинируют лиц из групп высокого риска, по эпидемическим показаниям — контактных в очагах генерализованной формы. По эпидемическим показаниям также прививают детей **от 1 года до 8 лет** включительно и студентов первых курсов.

Детей, перенёсших менингит и (или) менингоэнцефалит, наблюдает невролог **в течение 2 лет**: **через 1 месяц** после выписки, затем 1 раз в 3 месяца в первый год и 1 раз в 6 месяцев в дальнейшем.

5.2 Показания к госпитализации

Показания к госпитализации

1. подозрение на генерализованную форму — экстренно, в стационар с отделением реанимации;
2. необходимость изоляции при локализованной форме по эпидемиологическим показаниям;
3. серьёзные аллергические реакции на антибиотики в анамнезе.

Локализованные формы (назофарингит, носительство) лечат амбулаторно, если не требуется изоляция (дети дошкольного возраста в квартире, дома ребёнка, интернаты).

Критерии выписки

1. клиническое выздоровление;
2. нормализация лабораторных показателей.

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Менингококковая инфекция у детей»
Версия	2-я, опубликована в рубрикаторе 03.03.2023
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее 2026 года
Код в рубрикаторе	58_2 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Ассоциация врачей-инфекционистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области; Евро-Азиатское общество по инфекционным болезням
Пациенты	Дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Доза ампициллина при локализованных формах у детей массой до 20 кг указана как «12,5–25 мг/кг/сутки», а у детей более 20 кг — 250–500 мг каждые 6 часов (1–2 г в сутки): суточная доза для детей до 20 кг оказывается в несколько раз меньше; вероятно, имеется в виду доза на приём.